

POSTULANTE:

FECHA:

HORA:

HISTORIA CLINICA

Documento médico legal que descreve la cronologia de la enfermedad de paciente, corroborando diagnostico y conducta

SUBJETIVO responsabilidad del paciente

1. DATOS PERSONALES

- NOMBRE Y APELLIDOS
- EDAD
- SEXO
- ESTADO CIVIL
- OCUPACIÓN
- PROCEDENCIA
- RESIDENCIA
- RAZA
- RELIGIÓN
- ESCOLARIDAD

DIVISIÓN DE LA HC:

- 1.
- 2.

2. FUENTE DE LA HISTORIA EL PROPRIO PACIENTE QUE MEREZE CONFIANZA

3. MOTIVO DE CONSULTA QUEJA PRINCIPAL

- PALAVRAS DO PACIENTE
- OBJETIVA Y PRACTICA
- EJEMPLO

4. ENFERMEDAD ACTUAL

Preguntas sobre las quejas

- UTILIZANDO TERMINOLOGÍA MEDICA
- EJEMPLOS
 - DOLOR
ALICIA + signos y síntomas asociados



- VÓMITOS
Frecuenica/ Tipo/ Cantidad
- ALZAS TERMICAS
Cuantificadas o no

5. ANTECEDENTES PERSONALES

5.1 ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLÓGICOS

vivenda + hábitos de vida

- **VIVIENDA:** casa de adobe (chagas)
- **ALIMENTACIÓN:**
- **ALCOHOL:**
- **TABACO:**
- **DROGAS**
- **ATIVIDADES FISICAS** TIPO Y FRECUENCIA

5.2 ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

- **ENFERMEDADES DE LA INFANCIA:**
- **ENFERMEDADE DEL ADULTO:**
- **MEDICAMENTOS:** tiempo/ nombre/ frecuencia
- **INTERNACIÓN:** neumonia nosocomial?
- **QUIRÚRGICO:** ejemplo: obstrucción intestinal (cirugía anterior puede causar bridas y adherencias)
- **TRAUMAS:**
- **ALÉRGIAS:** shock anafilático

5.3 ANTECEDENTES FAMILIARES

enfermedades de su familia (1° grado) que puede tener.

DM, HTA, CHAGAS, ETILISMO, TABAQUISMO

- **MADRE:**
- **PADRE:**
- **HERMANOS**
- **HIJOS**
- **PAREJA**

5.4 ANTECEDENTES GOB

- **GPAC**
- **MENARCA**
- **TELARQUIA**
- **PUBARQUIA**
- **FUM**
- **PAP**
- **NUMERO DE PAREJAS**
- **ANTICONCEPCIÓN**
- **FPP**
- **CONTROLES PRENATALES**

6. REVISIÓN POR SISTEMAS

preguntas sobre otras sintomatologías del paciente haciendo una valoración completa del paciente.

- **SNC:** cefaleia, visión borrosa, mareos, somnolencia, convulsiones
- **SCP:** tos, disnea, palpitaciones, ortopnea, dolor toracico
- **SIGI:** dolor, náuseas, vómitos, hematemesis, hematoquecia
- **SGU:** disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, prurido, secreción
- **SME:** dolor, inflamación, tumefacción, rigidez, limitación de movilidad

(+)

(-)

OBJETIVO responsabilidad del medico**7. EXAMEN FÍSICO GENERAL**

Paciente en regular estado general, afebril, normohidratado, conciente e orientado en tiempo, espacio y persona.

FC:

FR:

PA:

T°:

SatO2:

8. EXAMEN FISICO REGIONAL

- **PIEL Y MUCOSAS:** DHT, ictericia
- **CABEZA:** alopecia, hematoma subgaleal
- **OJOS:** Mapache, escleras ictéricas, anisocoria...
- **OÍDOS:** simetria, CAE permeable
- **NARIZ:** forma, fosas nasales permeables.
- **BOCA:** simetria, orofaringe
- **CUELLO:** simetria, adenopatias
- **TORAX**
 - **INSPECCIÓN:**
 - **PALPACIÓN:**
 - **PERCUSIÓN:**
 - **AUSCULTACIÓN:**

CORAZÓN: focos cardíacos

PULMONES: estertores crepitantes, soplos, silbidos
- **ABDOMEN**
 - **INSPECCIÓN:** forma (TCS, embarazo), cicatriz
 - **AUSCULTACIÓN:** RHA normoactivos (5 a 35 x')
 - **PERCUSIÓN:**
 - **PALPACIÓN:** Murphy, Blumberg, Mcburney
- **GENITALES:** flujo, sangrado.
- **EXTREMIDADES:** tono (contracción natural), trofismo (desarrollo muscular)

9. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

MI / CIRU

GO

PE

10. ORDENES MEDICAS

1. INTERNACIÓN
2. MEDIDAS GENERALES
 - DIETA NPO, liquida, blanda, corriente, hipossódica, para diabético.
 - CONTROLES
 - POSICIÓN
 - DEAMBULACIÓN
 - CATETERES
3. SOLUCIONES (composición)
 - SF
 - RL
 - DEXTROSA
4. MEDICAMENTOS (POSOLOGÍA/VÍA/INTERVALO, STAT, DU)
5. EXAMENES COMPLEMENTARIOS
6. CONDUCTA QX (en caso px de cirugía: colecistitis, apendicitis)
7. COMUNICAR CAMBIOS

Erisipela

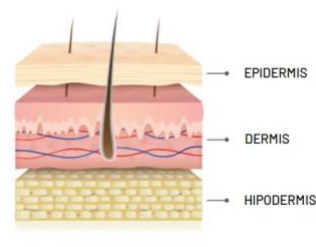
Definición: Es una infección dermoepidérmica, de rápido avance, producida por *estreptococo β -hemolítico del grupo A*.

Etiología: _____.

Fisiopatología:

La piel funciona como barrera, cuando hay una alteración de la misma, permite la entrada de gérmenes que colonizan este dicho órgano.

Ej.



Cuadro clínico: Se localiza en cualquier parte del cuerpo, pero predomina en cara (17%), piernas y dorso de los pies (76%).

La lesión típica es una placa **eritematosa y edematosa**, con **calor local** y **dolor intenso** asociado, se extiende por varios centímetros, con límites precisos y bordes bien definidos. Se acompaña de alzas térmicas, malestar general.

Diagnóstico:

- Clínica;

- Hemograma completo;
- **Reactante de fase aguda;**
- **Cultivo;**

Tratamiento:

- Amoxicilina + ácido clavulánico o dicloxacilina;
- Penicilina procaínica 800.000UI IM cada día por 10 días;
- Penicilina benzatínica 1.200.000UI IM cada 8 días durante 1 mes;

Complicaciones:

- Absceso;
- Glomerulonefritis;
- Carditis.

Celulitis

Definición: inflamación aguda del tejido celular subcutáneo originada principalmente por el _____.

Etiología: Staphylococcus aureus y Streptococo beta-hemolítico del grupo A.

Fisiopatología: comparte de la misma fisiopatología de la erisipela. Es más común en *pacientes diabéticos*.

Cuadro clínico:

Similar a la erisipela
Menos doloroso,
Extensión y los bordes son difíciles de delimitarlos.
Puede haber crepitos a la palpación.

**Diagnóstico:**

- Clínica;
- Hemograma completo;
- **Reactante de fase aguda;**
- **Cultivo;**

Tratamiento:

- Dicloxacilina;
- Amoxicilina + Ac. Clavulánico;
- Cefalosporina de tercera generación ;
- Cefalosporina de primera generación ;

HISTÓRIA CLÍNICA

	Erisipela	Celulitis
 Agente etiológico		
 Localización		
  Inicio		
 Bordes de la lesión		
 Eritema y calor local		
 Fiebre y malestar		
 Aspecto clínico		
 Tratamiento		